

Module B3.8 “Skills”

Sémiologie en Dermatologie

02-10-2023

Stéphanie Christen-Zäch, MD, MSCI, PD&MER

Unité de dermatologie pédiatrique

Services de Dermatologie & Pédiatrie



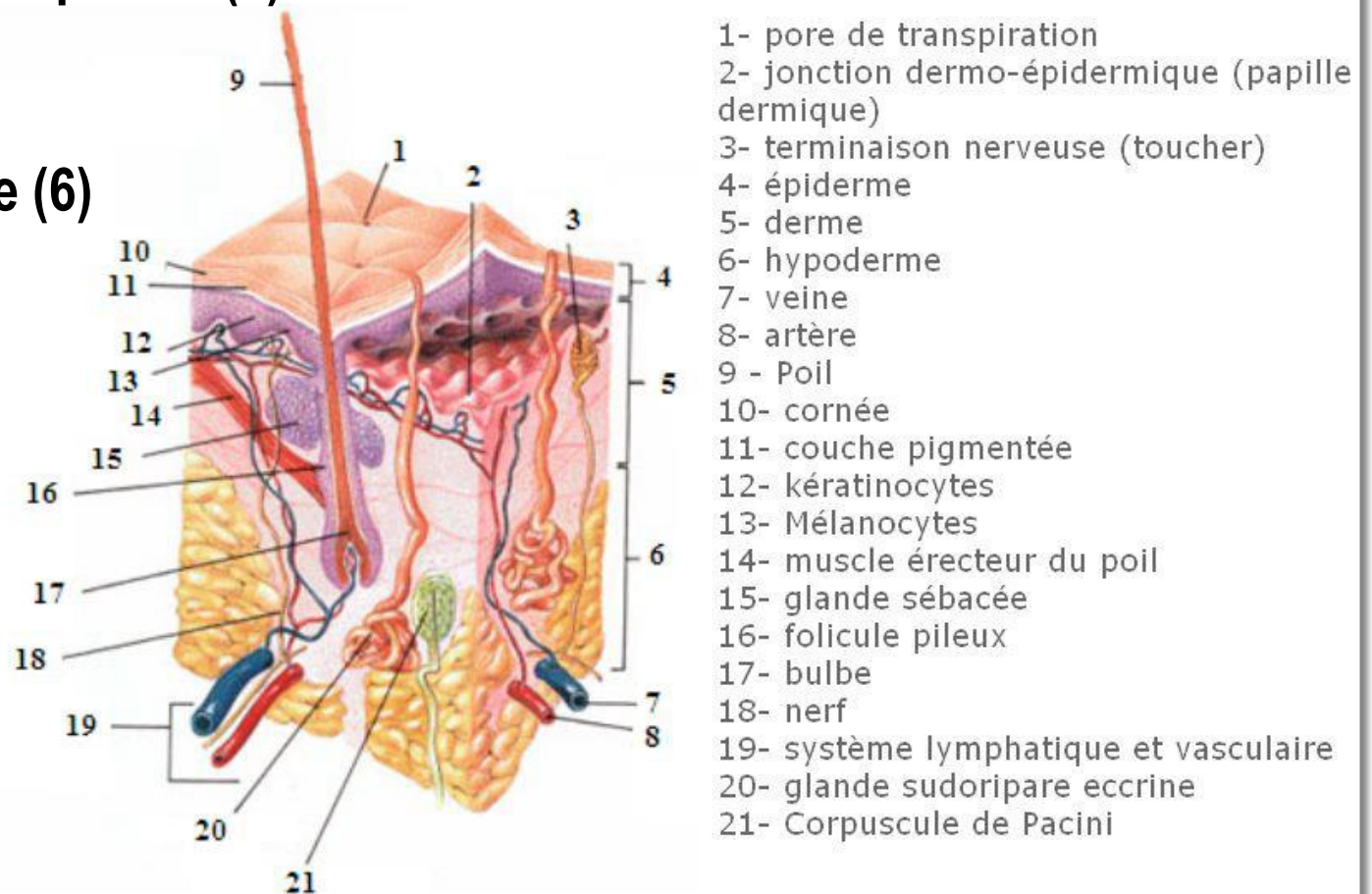
Objectif du cours

- Brève revue de l'anatomie de la peau
- Connaître l'examen dermatologique
 - L'anamnèse
 - Le status
 - Savoir reconnaître et décrire les principales lésions cutanées élémentaires
 - Pouvoir identifier les signes et symptômes associés aux dermatoses

Anatomie et histologie de la peau

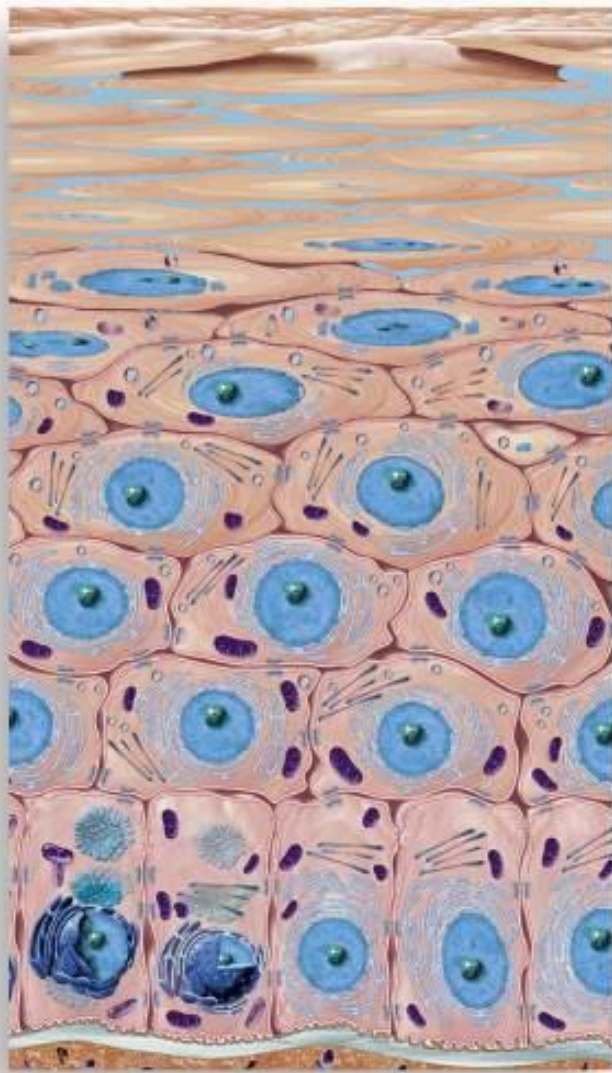
L'ensemble de la peau et ses phanères = tégument >> 3 parties

- Epiderme : partie superficielle, la plus mince (4)
- Derme : partie la plus épaisse (5)
- Hypoderme :
couche plus profonde (6)



Anatomie et histologie de la peau

Epiderme



Stratum corneum

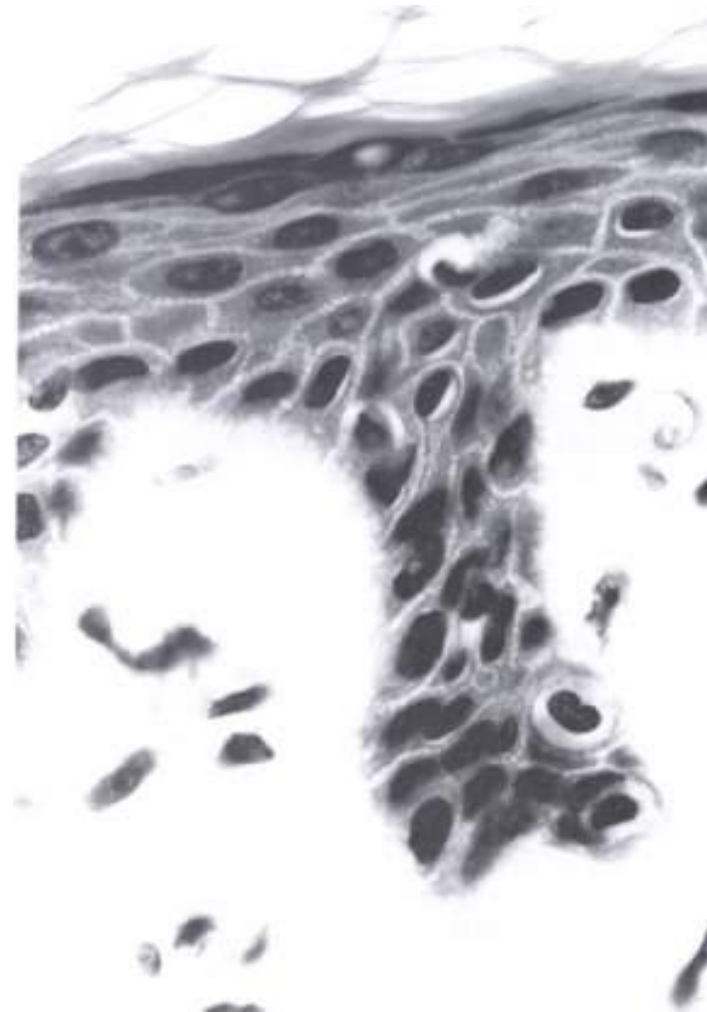
Stratum lucidum

Stratum granulosum

Stratum spinosum

Stratum basale

Basalmembran



L'examen dermatologique

- Anamnèse
- Examen clinique axé sur la lésion
- Examen général

N'oubliez pas, l'examen de la peau inclut :

- L'examen des phanères: ongles, cheveux et poils
- L'examen des muqueuses : organes génitaux et cavité buccale

Anamnèse dermatologique

Affection actuelle

- Mode de début (brutal ou progressif, localisé ou d'emblée étendu)
- Mode évolutif (aigu, chronique, par poussée...)
- Localisation (localisé ou étendu, atteinte des muqueuses ou organes génitaux)
- Mode d'extension (centrifuge, curviligne, en plaques...)
- Traitements locaux utilisés
- Signes associés à la dermatose (prurit, brûlures, douleurs, état fébrile, arthralgies...)

Anamnèse dermatologique

Anamnèse personnelle

- Exposition à des substances toxiques/irritantes ou sensibilisantes
- Exposition aux UV et l'effet sur la dermatose
- Prise de médicaments systémique ou topique
- Soins cutanée habituel
- Contact sexuel
- Voyages, anamnèse de contact
- Infections, immunosuppression
- Atopie, allergies

Anamnèse dermatologique

Anamnèse familiale

- Génodermatoses, problèmes héréditaires en général
- Infections, immunosuppression
- Maladie auto-immunes
- Allergies / atopie

Status dermatologique

L'examen clinique doit se faire dans un endroit correctement éclairé

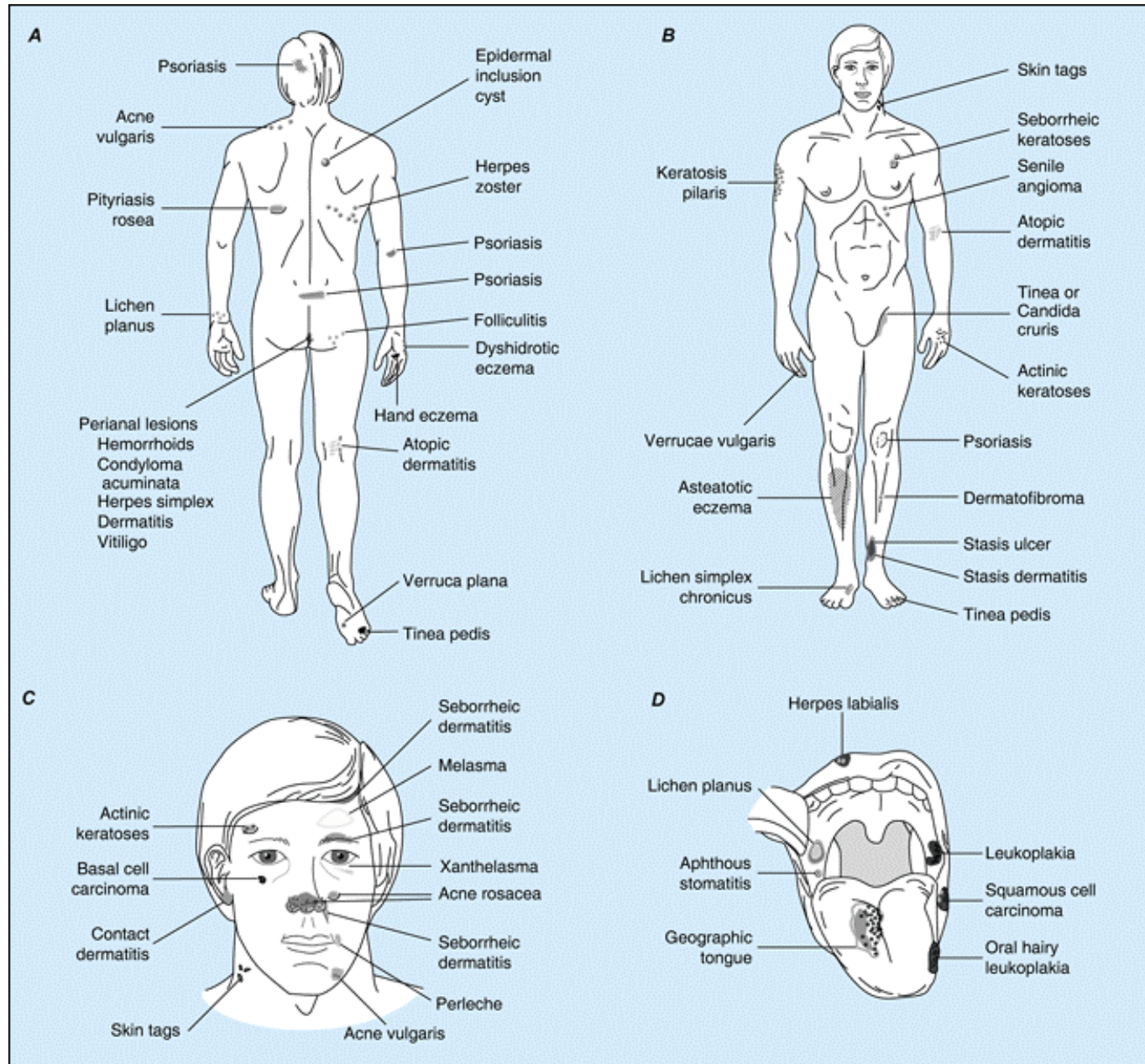
L'ensemble du tégument est examiné

- Cheveux, ongles, muqueuses, régions ano-génitales, ombilic, plis rétro-auriculaires, paumes et plantes

Durant l'examen, il faut se poser les questions suivantes

- Quelle est la topographie des lésions?
- Quelle est la répartition et disposition de la lésion ?
- Quelle est la forme de la lésion ?
- Quelles sont les dimensions et couleurs des lésions cutanées ?
- Certaines lésions doivent être observées à la lumière ultraviolette

Quelle est la topographie des lésions?



Quelle est la répartition des lésions?

localisée



disseminées



bilateral



unilateral



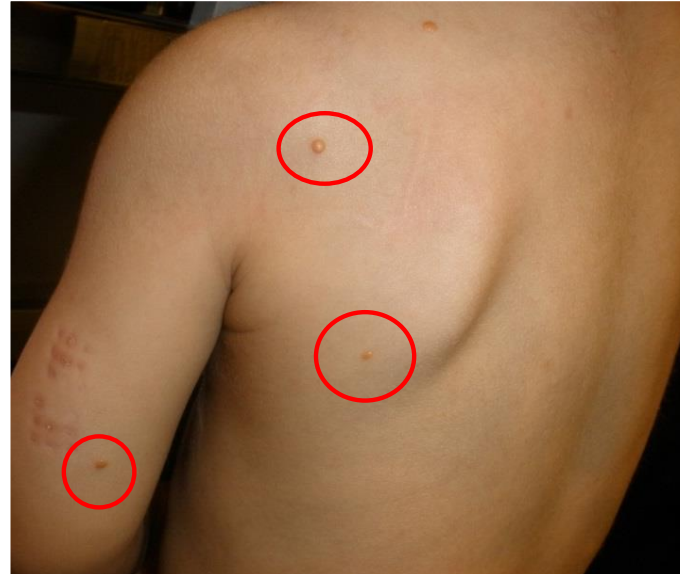
Quelle est la disposition de la lésion ?

- **Solitaire**
- Multiple
 - au hasard
 - regroupée
 - linéaire
 - segmentaire
 - folliculaire



Quelle est la disposition de la lésion ?

- Solitaire
- **Multiple**
 - **au hasard**
 - **regroupée**
 - linéaire
 - segmentaire
 - folliculaire

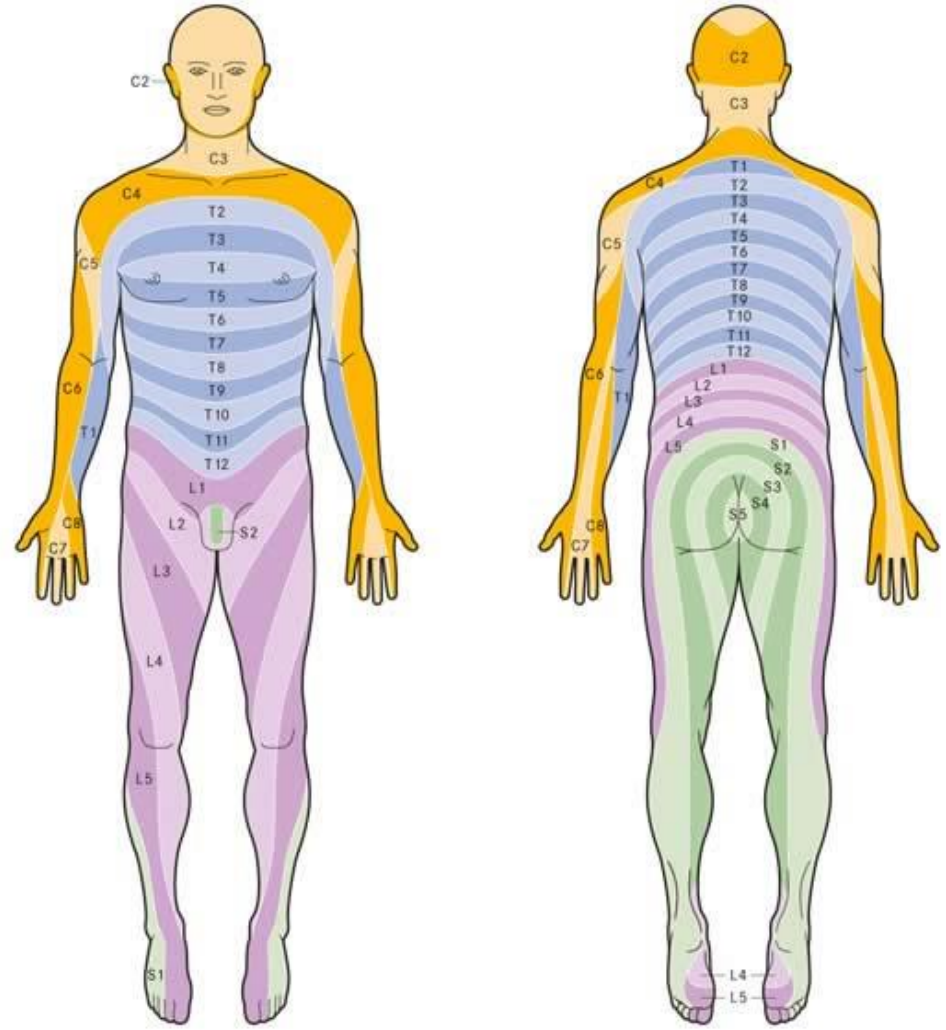
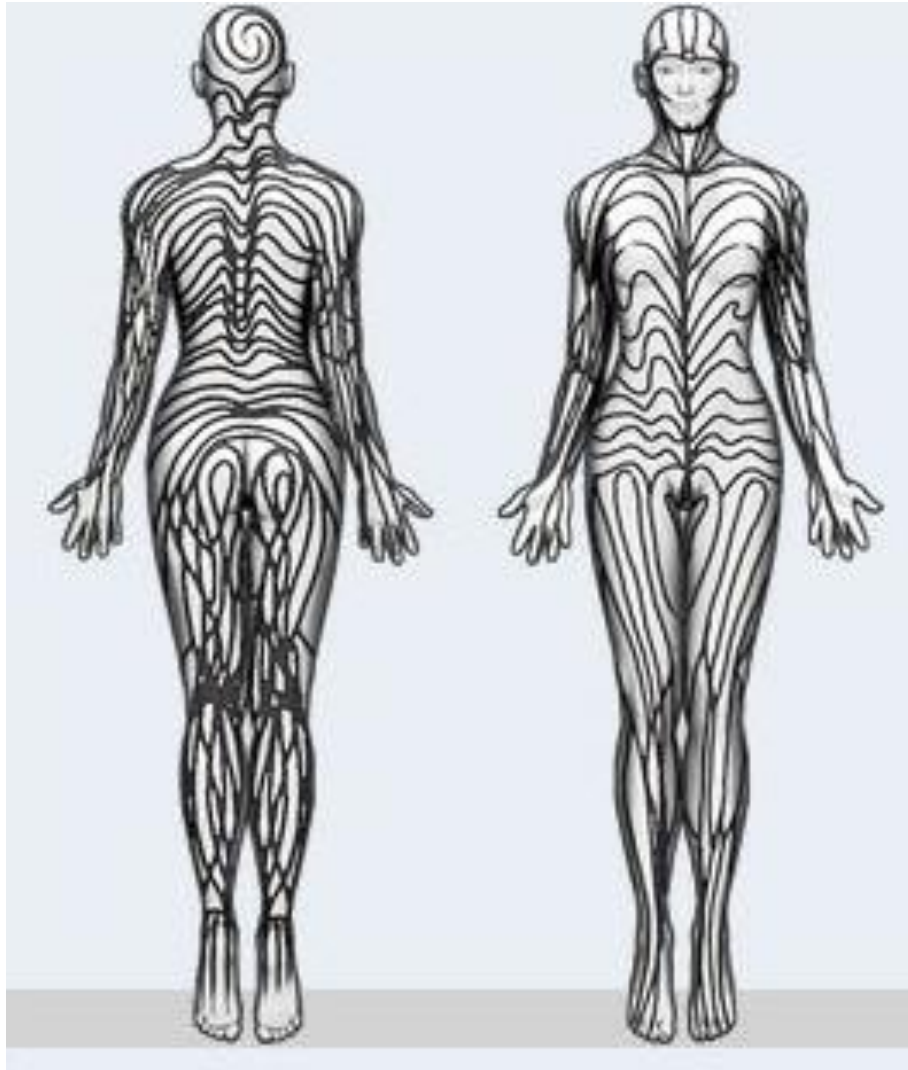


Quelle est la disposition de la lésion ?

- Solitaire
- **Multiple**
 - au hasard
 - regroupée
 - **linéaire**
 - **segmentaire**
 - folliculaire



Lignes de Blaschko versus Dermatomes



Quelle est la disposition de la lésion ?

- Solitaire
- **Multiple**
 - au hasard
 - regroupée
 - linéaire
 - segmentaire
 - **folliculaire**



Quelle est la forme de la lésion ?

Bord mal délimité



bien délimité



Quelle est la forme de la lésion ?

Nummulaire



Annulaire



Cocardiforme



Polycyclique



Arciforme



Quelles sont les dimensions et



couleurs des lésions cutanées ?



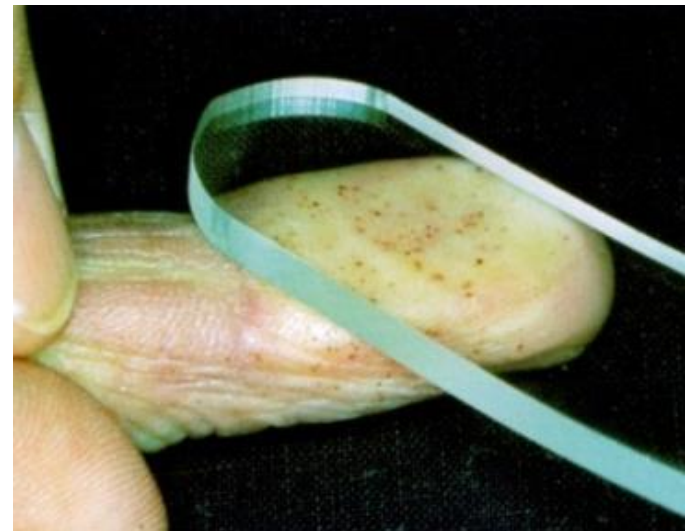
Palpation et vitropression

La palpation

- Elle permet d'apprécier le relief d'une lésion
- Pensez à vous protéger par un gant d'examen en cas de lésion suintante

La vitropression

- Elle fait disparaître la congestion vasculaire, permettant par exemple de différencier entre un purpura et une simple macule qui disparaît à la vitropression.



Friction et curettage

La friction

- De la peau peut occasionner :
 - Un dermographisme : rouge, blanc, surélevé



- Un décollement cutané -> signe de Nikolsky

Le curettage

- Permettant de détacher les croûtes et d'analyser la lésion sous-jacente.
- Dans le psoriasis le décapage de la dernière squame laisse apparaître des petits points hémorragique c'est le signe de la « rosée sanglante ».

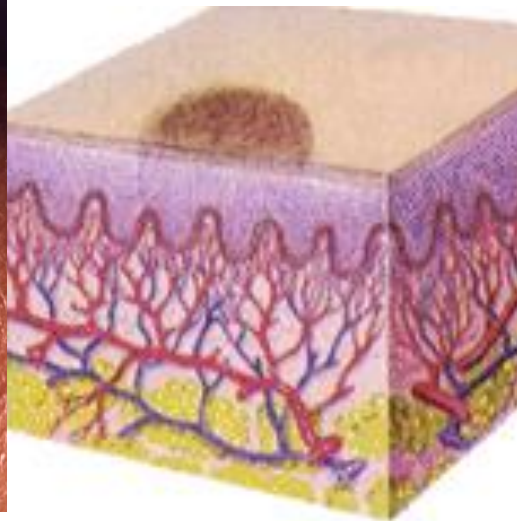
Description des lésions cutanées

- **Lésion élémentaire primitive**
 - **Macule**
 - **Papule**
 - **Nodule**
 - **Plaque**
 - **Pustule**
 - **Vésicule**
 - **Bulle**
 - **Urticaire**

Macule

Tache cutanée circonscrite, sans relief ni infiltration

Simple modification de la couleur de la peau



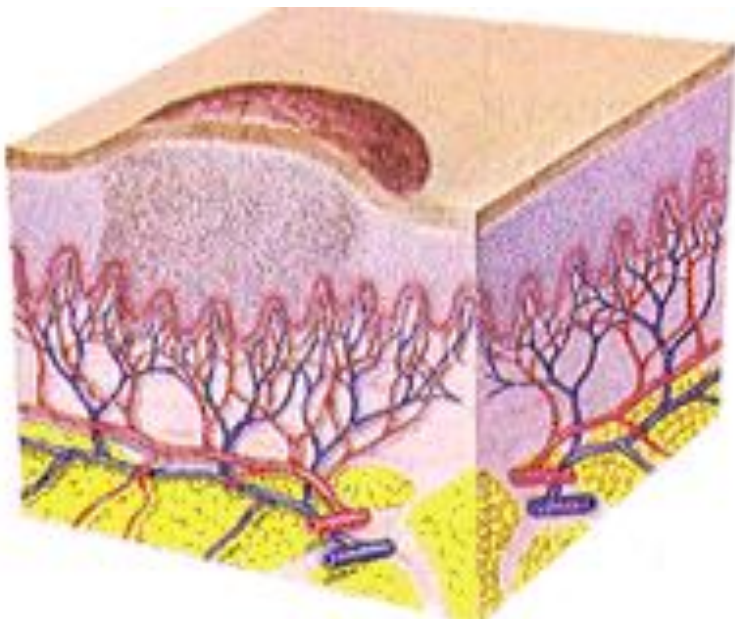
Vitiligo



Papule

Petite lésion cutanée de $< 1\text{cm}$ de diamètre

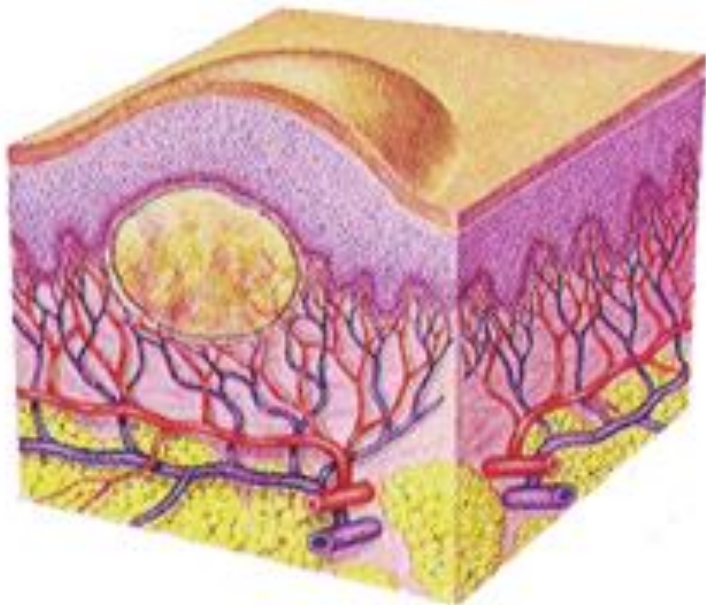
Bien délimitée, en relief, ne contenant pas de liquide



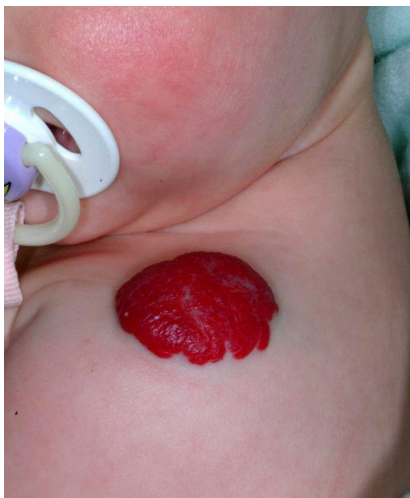
Nodule

Elevure cutanée ronde, saillante, palpable, de diamètre >1 cm

Résultant soit d'un oedème, soit d'un infiltrat inflammatoire ou tumoral dermique ou hypodermique



Hémangiome infantile



superficiel

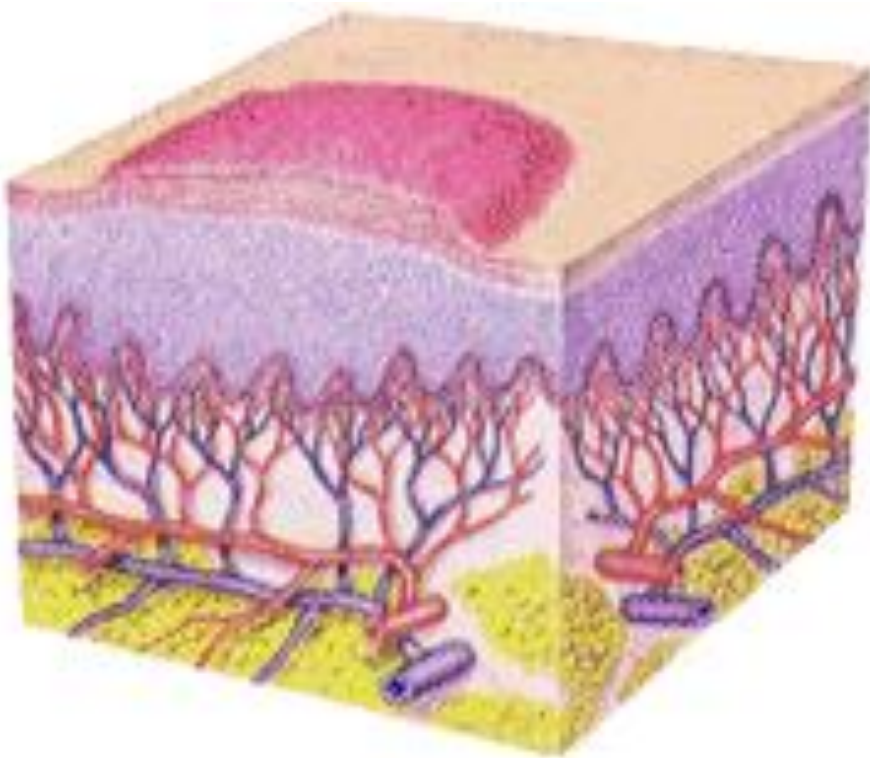


profond



mixte

Plaque



Dermatite de contact au nickel



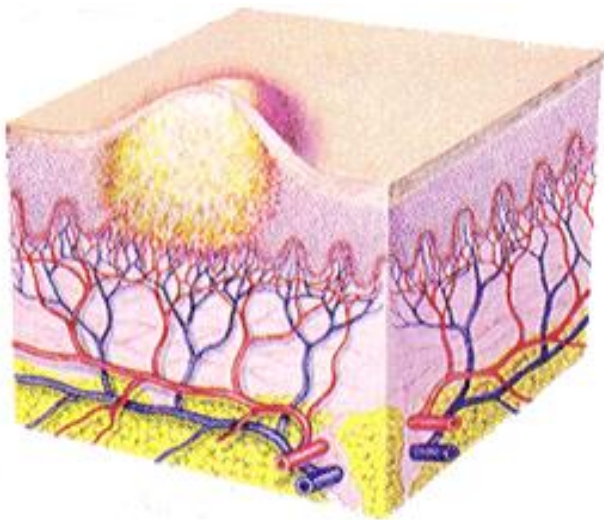
**Boutons pression en
métal sur les jeans**



Pustule

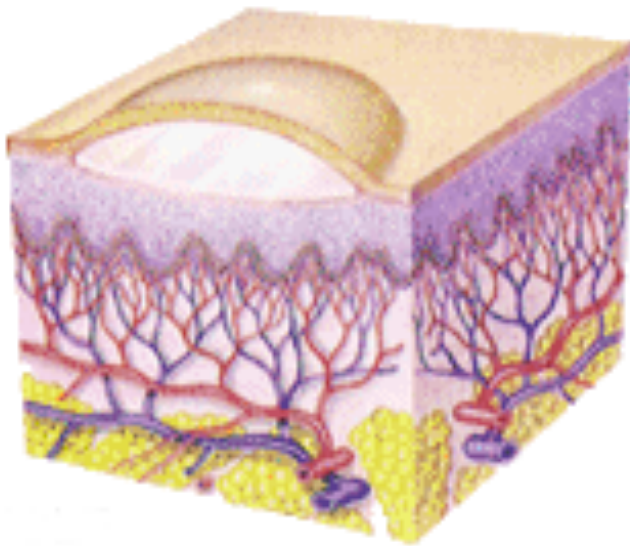
Petite cavité remplie de pus (stérile/non stérile)

folliculaire ou non folliculaire



Vésicule

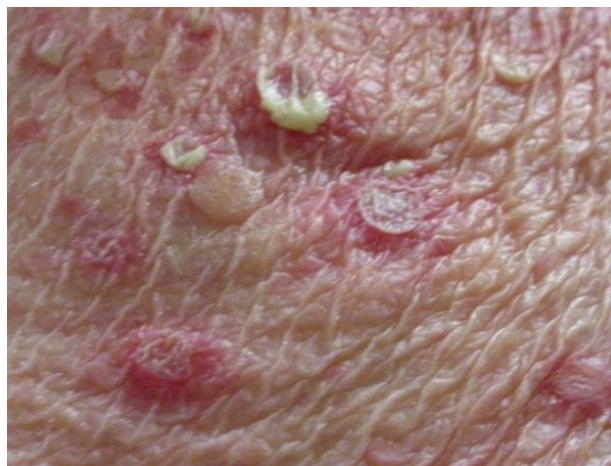
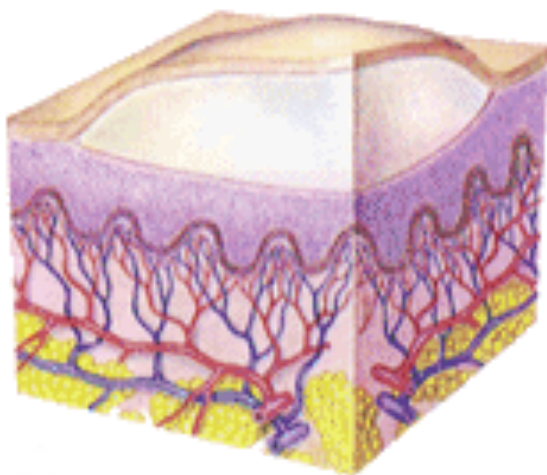
Petite cavité intraépidermique à contenu liquidien



Bulle

Soulèvement circonscrit de l'épiderme, de volume $>$ à celui d'une vésicule

Contient un liquide clair ou séropurulent ou hémorragique



Impétigo bulleux



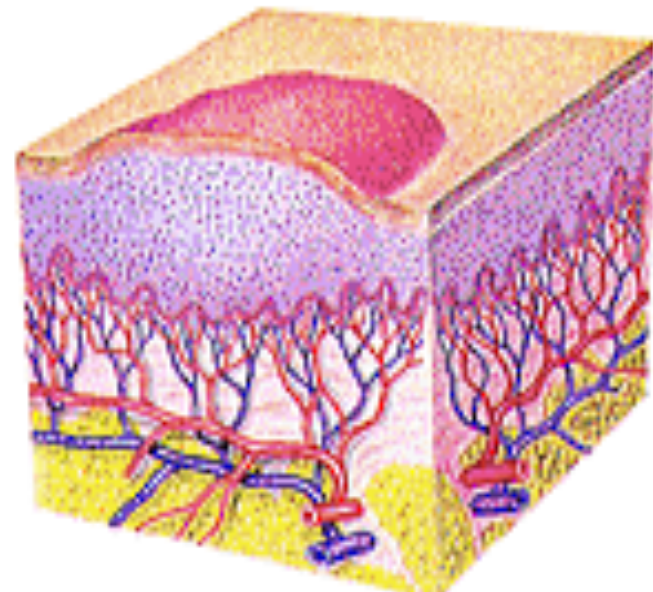
Infection à
staphylococcus aureus
avec
toxine épidermolytique

Urticaire



Eruption cutanée brutale de papules prurigineuses, œdémateuses, à limites nettes, de taille, de forme et de siège très variables

persiste < de 24 heures



Urticaire

Forme classique avec vasoconstriction au pourtour
Dermographisme



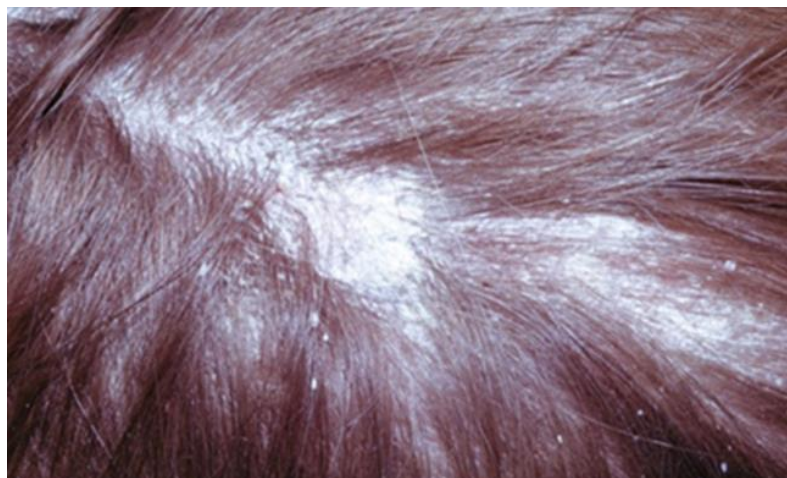
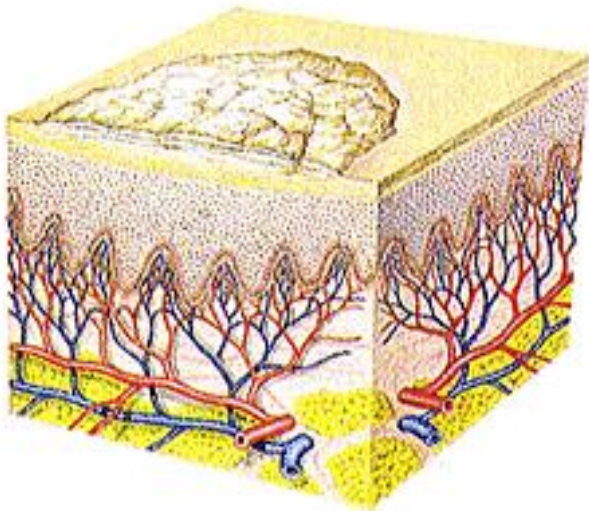
Description des lésions cutanées

- **Lésions élémentaires secondaires**
 - **Squame**
 - **Croûte**
 - **Fissure**
 - **Erosion**
 - **Excoriation**
 - **Ulcère**
 - **Atrophie**
 - **Lichénification**
 - **Cicatrice**

Squame

Epaississement de la couche cornée qui se détache par grattage tangentiel doux de la surface cutanée

- Pityriasiforme
- Psoriasiforme
- En collerette
- Lamellar
- Ichtyosiforme



Psoriasis



Ichtyose

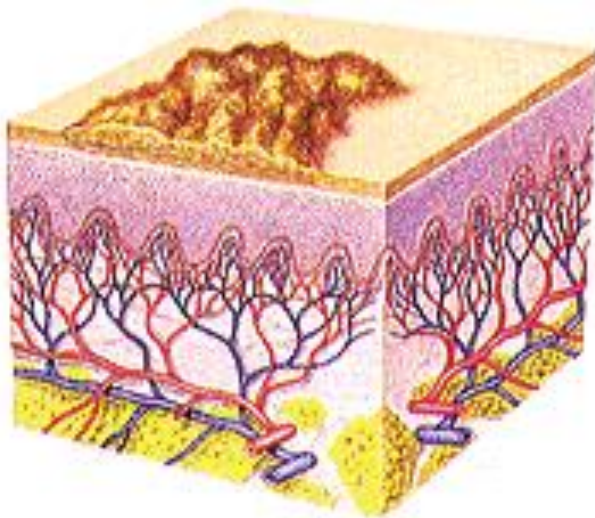


Croûte

Formation dure, recouvrant une plaie ou une excoriation cutanée

Dessiccation d'un exsudat séreux, hémorragique ou purulent

Facilement détachable en bloc d'un coup de curette



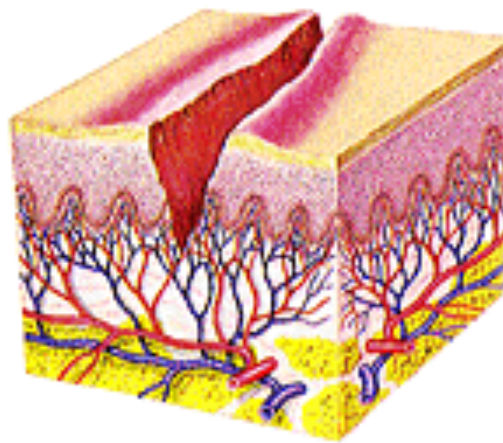
La Gale

Papules érythémateuses, vésicules et plaques excoriées sur le tronc, les extrémités, les paumes et plantes des pieds



Rhagade (Fissure)

Perte de substance linéaire



Excoriation

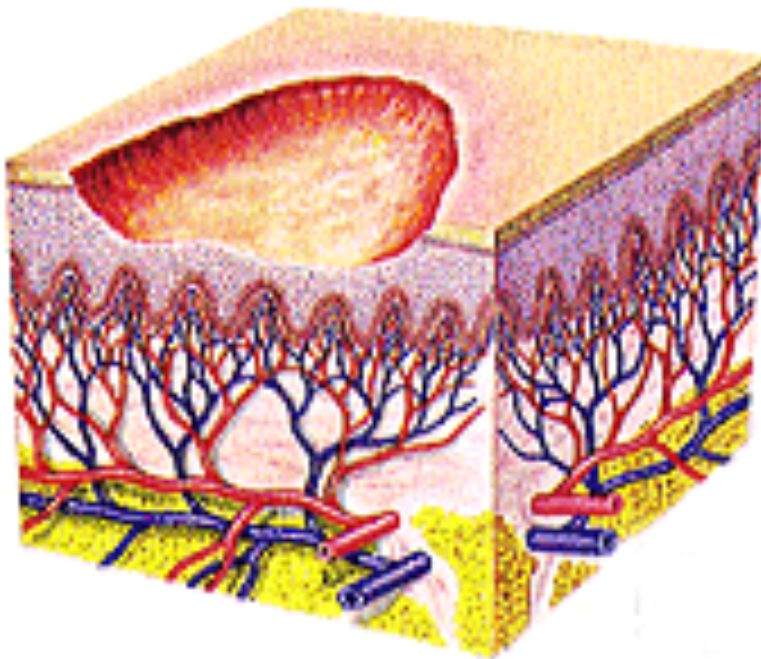


Abrasion linéaire des couches superficielles de l'épiderme généralement causée par le grattage

Erosion

Perte de substance cutanée ou muqueuse superficielle

Ne laisse pas de cicatrices

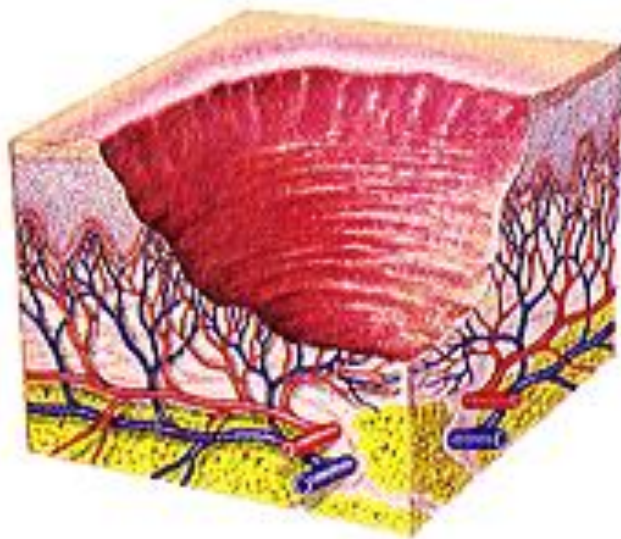


Ulcère

Perte de substance localisée suite à un traumatisme ou une nécrose

Entamant au moins le derme moyen et profonde

Ne pouvant guérir sans laisser de cicatrice



Pyoderma gangrenosum

- Dermatose neutrophile inflammatoire stérile
- Stéroïdes systémiques: 2 mg/kg/jour pendant 3 jours puis 1mg/kg/jour pendant 3 mois
- & Protopic 0.1% onguent 2x/jour

Situation initiale

1 mois

2 mois

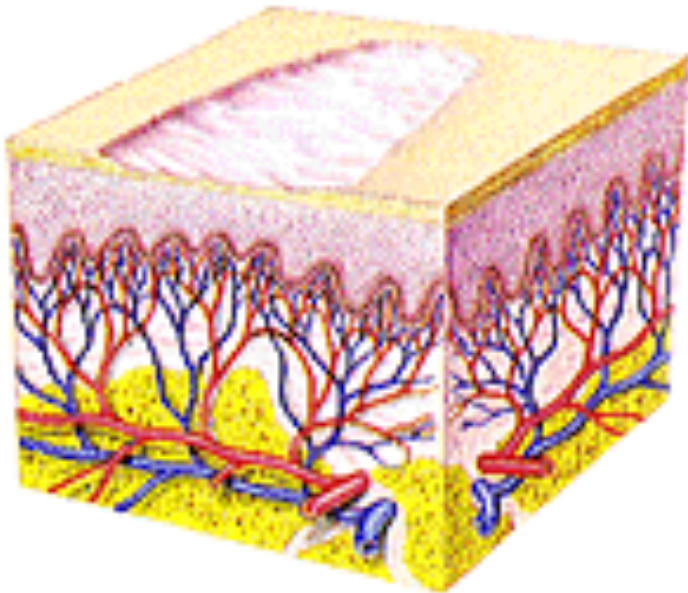
6 mois



Atrophie

Amincissement du tégument, lisse et nacré

Perte de l'élasticité, du relief, des annexes



Aplasie cutanée congénitale

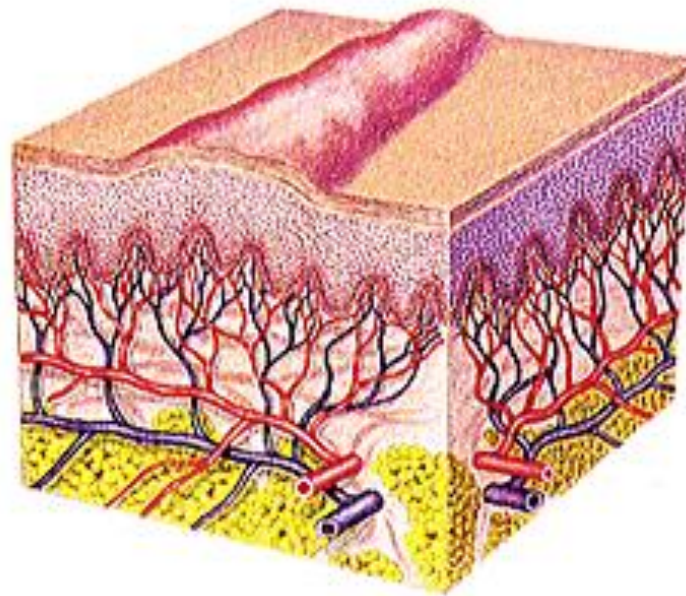


Morphée



Cicatrice

Cicatrice cutanée caractérisée par son caractère hypotrophique ou hypertrophique, en relief, sans extension au-delà de la zone lésée





Poïkilodermie

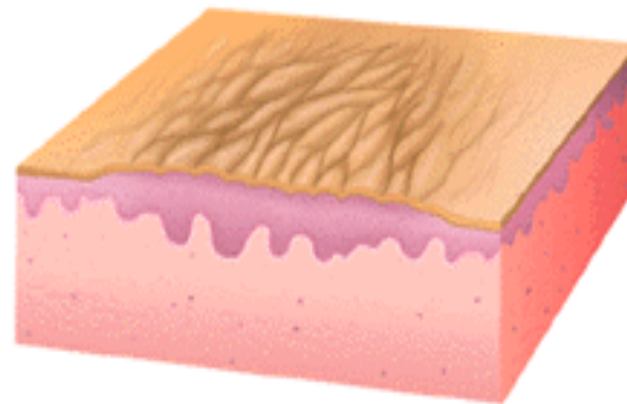
Etat bigarré de la peau. Triade caractéristique: atrophie cutanée, téléangiectasies et troubles pigmentaires (hyper- resp. hypopigmentation)



Lichénification

Accentuation du quadrillage de la peau épaissie et brillante.

Typiquement associé à un prurit important



Eczéma atopique avec plaques lichenifiées





stephanie.christen@chuv.ch